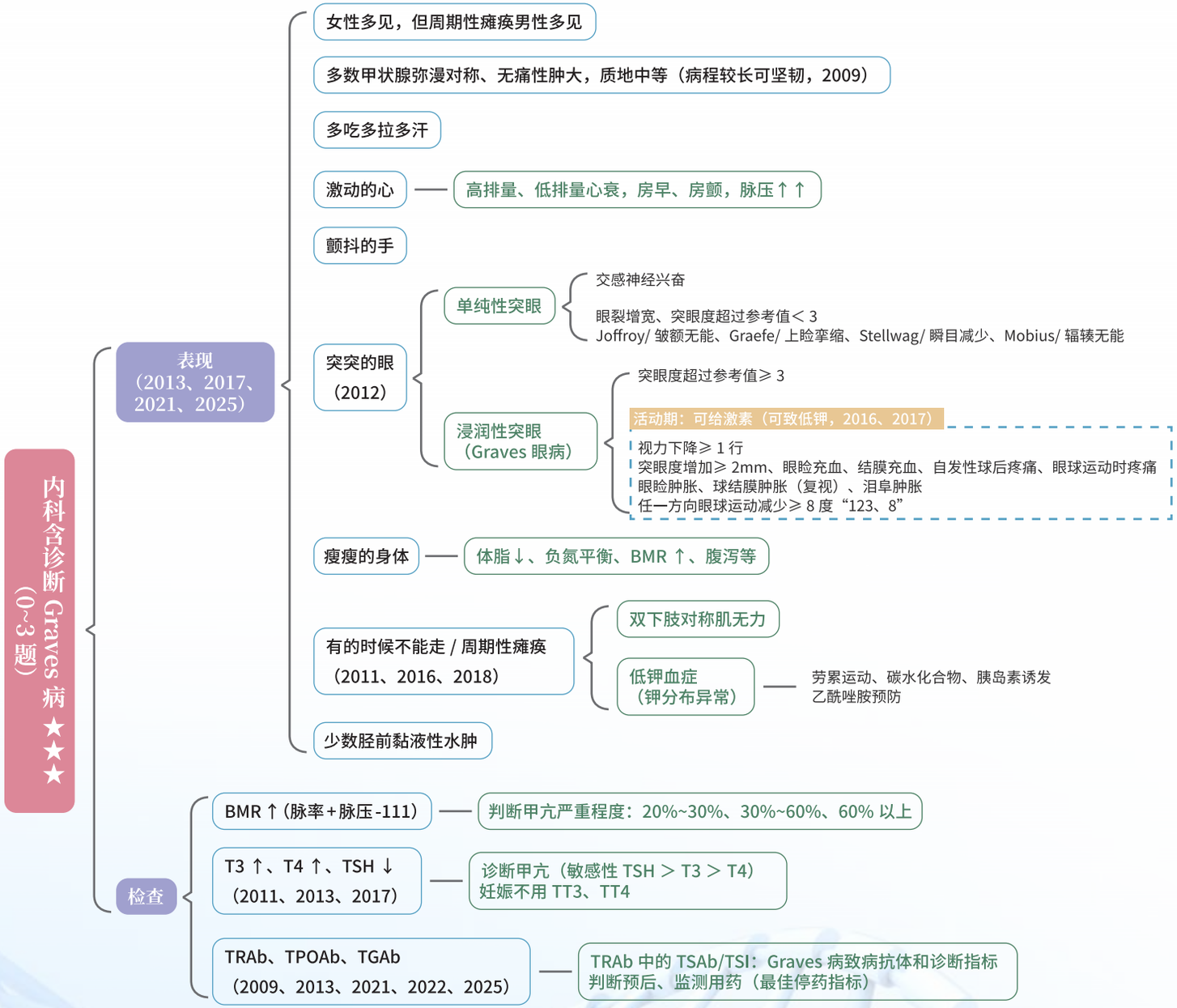

内科含诊断 Graves 病 ★★★
（0~3 题）
表现
（2013、2017、2021、2025）
女性多见，但周期性瘫痪男性多见
多数甲状腺弥漫对称、无痛性肿大，质地中等（病程较长可坚韧，2009）
多吃多拉多汗
激动的心
高排量、低排量心衰，房早、房颤，脉压↑↑
颤抖的手
突突的眼
（2012）
单纯性突眼
交感神经兴奋
眼裂增宽、突眼度超过参考值＜ 3
Joffroy/ 皱额无能、Graefe/ 上睑挛缩、Stellwag/ 瞬目减少、Mobius/ 辐辏无能
浸润性突眼
（Graves 眼病）
突眼度超过参考值≥ 3
活动期：可给激素（可致低钾，2016、2017）
视力下降≥ 1 行
突眼度增加≥ 2mm、眼睑充血、结膜充血、自发性球后疼痛、眼球运动时疼痛
眼睑肿胀、球结膜肿胀（复视）、泪阜肿胀
任一方向眼球运动减少≥ 8 度“123、8”
瘦瘦的身体
体脂↓、负氮平衡、BMR ↑、腹泻等
有的时候不能走 / 周期性瘫痪
（2011、2016、2018）
双下肢对称肌无力
低钾血症
（钾分布异常）
劳累运动、碳水化合物、胰岛素诱发
乙酰唑胺预防
少数胫前黏液性水肿
检查
BMR ↑（脉率 + 脉压 -111）
判断甲亢严重程度：20%~30%、30%~60%、60% 以上
T3 ↑、T4 ↑、TSH ↓
（2011、2013、2017）
诊断甲亢（敏感性 TSH ＞ T3 ＞ T4）
妊娠不用 TT3、TT4
TRAb、TPOAb、TGAb
（2009、2013、2021、2022、2025）
TRAb 中的 TSAb/TSI：Graves 病致病抗体和诊断指标
判断预后、监测用药（最佳停药指标）